Universidad Diego Portales
Facultad de Psicología
Carrera de Psicología

I. Identificación del curso:

Nombre de la asignatura: **INTRODUCCION A LA NEUROPSICOLOGÍA CLINICA**
Código: PSI4436
Requisitos: No
Horario: Martes 1-3
Sala: 207
Créditos: 4
Horas presenciales: 2
Horas no presenciales: 5
Profesor: Christian Salas Riquelme
Ayudante: Antonia Quevedo
Semestre/año en que se dicta: 2º semestre 2026

II. Descripción:

La Neuropsicología Clínica (NC) es una sub-especialidad de la psicología clínica que tiene como principal objetivo la aplicación de conocimientos de la psicología clínica en la evaluación e intervención de personas con trastornos del sistema nervioso central a lo largo del ciclo vital. De forma de ofrecer un cuidado psicológico adecuado a estas personas y sus familias, los neuropsicolog@s clínic@s poseen un conocimiento especializado sobre la relación de la conducta humana y el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central.

En Chile existe una gran población de adult@s y niñ@s que presentan alteraciones motoras, cognitivas, socio-emocionales y conductuales debido a trastornos del sistema nervioso central. Tanto la detección y diagnóstico oportuno de estas poblaciones, como su tratamiento adecuado, requieren del input de neuropsicólog@s clínic@s. Debido al desarrollo de políticas de salud existe una creciente demanda a nivel primario, secundario y terciario de profesionales adecuadamente entrenados en los fundamentos teóricos y técnicos de la neuropsicología clínica.

Este curso pertenece a una nueva línea de desarrollo curricular en psicología clínica en la UDP, la cual tiene como objetivo introducir a estudiantes en la disciplina de la neuropsicología clínica y sus aplicaciones. Este curso antecede, y es un requisito, del taller “Introducción a la evaluación neuropsicológica en Adultos”. Ambos cursos son pre-requisitos de la práctica profesional en la Unidad de Neuropsicología Clínica de la UDP.

Este curso ofrecerá a los estudiantes una primera aproximación a la Neuropsicología Clínica, enfocándose en poblaciones neurológicas adultas. Este curso entregará una valiosa herramienta para el desempeño laboral de los

estudiantes en diversos contextos púbicos y privados de salud. Al finalizar el curso el estudiante poseerá un conocimiento básico de neuroanatomía funcional y estará familiarizado con las patologías cerebrales más comunes y sus perfiles neuropsicológicos. El estudiante comprenderá el impacto psicosocial de los trastornos neurológicos a nivel individual y sistémico. Se familiarizará con los principios teóricos y técnicos de la evaluación y rehabilitación neuropsicológica, con un especial énfasis en el uso y adaptación de intervenciones psicológicas individuales y familiares.

Este curso contribuirá al perfil de egreso de los estudiantes a través de la entrega de herramientas teóricas y técnicas para el diseño y ejecución de diagnósticos neuropsicológicos en diversos contextos. Debido a la carencia de psicólogos especializados en neuropsicología en Chile, este curso contribuirá a satisfacer las necesidades de diversas poblaciones con problemas neurológicos o neuropsiquiátricos.

III. Objetivos:

Objetivo general

- Al finalizar el curso el estudiante conocerá los fundamentos teóricos, técnicos y éticos de la Neuropsicología Clínica.

Objetivos específicos

- Al finalizar el curso el estudiante conocerá las patologías cerebrales más comunes y sus perfiles neuropsicológicos correspondientes.
- Al finalizar el curso el estudiante conocerá los aspectos neuropsicológicos de diversas patologías médicas y psiquiátricas.
- Al finalizar el curso el estudiante se familiarizará con los fundamentos teóricos y técnicos de la evaluación neuropsicológica.
- Al finalizar el curso el estudiante se familiarizará con los fundamentos teóricos y técnicos de la rehabilitación neuropsicológica.
- Al finalizar el curso el estudiante se familiarizará con los fundamentos teóricos y técnicos de las intervenciones psicológicas individuales y familiares en personas con patología neurológica.

IV. Metodología:

La metodología a utilizar en el curso es presencial más trabajo personal asincrónico. Cada semana se impartirá un módulo temático. Previo a cada módulo los estudiantes deberán preparar el material de estudio: cápsulas, lectura personal y guías de material audiovisual. Durante la clase presencial se discutirán y profundizarán los contenidos teóricos y revisará material audio-visual relacionado (ej. entrevistas, evaluación, intervenciones psicológicas, etc). Además, los alumnos expondrán de forma grupal contenidos de profundización asociados a los módulos.

Las clases presenciales serán realizadas durante los módulos 2-3

V. Evaluación:

El curso será evaluado de la siguiente forma:

2 solemnes del contenido teórico-clínicas (25% c/u, total 50%). Las solemnes serán realizadas de forma presencial durante una hora académica. Notas bajo 4.0 en solemne implica que el estudiante debe dar examen.

Controles de Lectura (20%). Cada lectura será evaluada al comienzo de la clase por medio de un control con preguntas breves de desarrollo. Al final del semestre se borrará las dos notas más bajas de estos controles. No existen controles de lectura recuperatorios.

Trabajo Personal (20%) El material audiovisual y escrito de cada semana será evaluado a través de una guía relativa a los contenidos centrales del material complementario. Este trabajo es semanal y deberá ser entregado antes de la clase sincrónica (Martes 9:00 AM). Si el estudiante no envía el trabajo en la fecha y hora acordada será calificado con nota 1.0. Al final del semestre se borrarán la dos notas más bajas. No será posible recuperar guías de trabajo personal no entregadas.

Presentación (10%). Los alumnos deberán presentar los contenidos centrales de un texto (en inglés) durante la clase presencial. Dicha presentación deberá ser acompañada de un resumen de 1 página el cual debe ser entregado el mismo día de la presentación (se adjunta guía de presentación y formato hoja resumen). Los contenidos de las presentaciones grupales serán incluidos en las solemnes.

El estudiante tiene derecho a rendir una solemne recuperativa sin explicación. La prueba recuperativa de las solemnes incluirá información de todos los contenidos del ramo. Si renuncia, incluso tácitamente, a este derecho, mantendrá su calificación inicial de 1.0. No se podrá recuperar más de una solemne, independientemente de las causas de las inasistencias.

La nota de aprobación de curso es un 4.0. La nota de eximición a examen es 5.5. Para la eximición se requiere haber obtenido nota superior a 4.0 en ambas solemnes. La nota de presentación a examen es de 3.5 a 5.4. La nota del examen equivale a un 30% de la nota final del curso.

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO

1. ASISTENCIA

1.1. Requisito de Asistencia:

De acuerdo al Reglamento del Estudiante de Pregrado, el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos del primer año de la carrera será del 70%. Para el resto de los cursos, cada docente decidirá el porcentaje de asistencia que considera adecuado pero, una vez señalado en su programa, debe ser consistente y mantenerlo. Si el curso no contempla regla de asistencia, se entiende que esta se encuentra liberada.

Artículo 26 del Reglamento del estudiante de Pregrado: El estudiante que no cumpliere con el requisito mínimo de asistencia en un determinado curso, no tendrá derecho a rendir la evaluación final. En tal caso se considerará como nota final del curso, el promedio ponderado de las evaluaciones parciales si este fuera inferior a 4,0. Si el promedio fuere igual o superior a 4,0, se consignará la notación RI (reprobación por inasistencia), la que será equivalente a un 3,9 para efectos del cálculo del promedio de notas.

1.2. Sobre la Inasistencia a Actividades Obligatorias:

La inasistencia a una actividad de asistencia obligatoria deberá ser comunicada y justificada por escrito a Secretaría de Estudios dentro del plazo de 48 horas hábiles, a contar de la fecha de inasistencia. Se deberá acompañar un documento que acredite la causa de la inasistencia. Tratándose de licencias médicas, éstas deben incluir el timbre del establecimiento, nombre y rut del facultativo, más la boleta o registro de atención.

En el caso de estudiantes que sean padres o madres se puede justificar inasistencia por razones de salud del hijo o la hija, con el correspondiente certificado médico del niño o niña menor de edad, o bien el documento donde conste la asistencia a controles médicos. Los certificados deberán ser presentados ante la Secretaría de Estudios dentro de los 5 días siguientes a la inasistencia. Se eximen de esta regla todas aquellas actividades docentes que directa e inmediatamente afecten derechos o intereses de terceros y aquellas que por su índole no puedan ser repetidas o sustituidas por otra equivalente.

En el caso de estudiantes que tienen cargos en la mesa directiva de la FEDEP UDP o que sean electos como consejeros estudiantiles del Consejo Académico, se eximirán del deber de asistencia a clases por el período en que ejerzan sus cargos. En el caso de estudiantes que han sido electos para la mesa directiva de un Centro de Estudiantes o que sean electos como consejeros ante el Consejo de Facultad, pueden justificar inasistencia por razones del ejercicio de su cargo ante la Secretaría de Estudios, hasta dentro de los 3 días siguientes a la inasistencia. Se eximen de esta regla todas aquellas actividades docentes que directa e inmediatamente afecten derechos o intereses de terceros y aquellas que por su índole no puedan ser repetidas o sustituidas por otra equivalente.

1.3. Sobre la Inasistencia a evaluaciones y exámenes:

Tal como señala el Reglamento de Evaluación y Promoción de Estudiantes de la Facultad de Psicología, antes del examen de cada asignatura, el o la estudiante tendrá derecho a rendir una prueba recuperativa, para recuperar una nota producto de la ausencia a evaluaciones parciales producidas en el semestre. Si renuncia, incluso tácitamente, a este derecho, mantendrá su calificación inicial de 1.0. No se podrá recuperar más de una nota, independientemente de las causas de las inasistencias.

2. ACERCA DE LAS RELACIONES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD[1]

De acuerdo al Reglamento de Convivencia Estudiantil[2] “uno de los postulados fundamentales de la Universidad Diego Portales es el respeto a la libertad de pensamiento y a las distintas creencias. Asimismo, la Universidad declara su irrestricta adhesión y respeto a la dignidad e igualdad de las personas. Todos los que forman parte de la comunidad universitaria -estudiantes, académicos, funcionarios y directivos- son libres e iguales y así serán tratados”.

Así, el trato con respeto y consideración es obligación de todos los miembros de la comunidad, debiendo asumir la obligación de observar un correcto y adecuado comportamiento, con el objeto de mantener una sana convivencia universitaria.
La Universidad Diego Portales también prohíbe todas las formas de discriminación arbitraria entre sus estudiantes, es decir, aquella que carece de razones que justifiquen el trato diferente por razones de sexo, edad, género, discapacidad, nacionalidad, condición social, u otras.

Las siguientes normativas pueden ser aplicables en cada caso:

---

[1] Cf.: Reglamento de Convivencia Estudiantil, Reglamento del Académico, Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual

[2] El reglamento de Convivencia estudiantil se encuentra disponible en: https://www.udp.cl/wp-content/uploads/2017/11/Reglamento_de_Convivencia_Estudiantil.pdf

- Entre estudiantes: El "Reglamento de Convivencia Estudiantil" establece sanciones leves, graves y gravísimas (art. 1, 2 y 3). En estos casos será el Decano, el Director de Escuela o el Tribunal de Honor de la Universidad, dependiendo de la falta que se trate, el que decidirá las sanciones correspondientes.
- Entre académicos y estudiantes: Frente a la denuncia de un/a estudiante/a, el "Reglamento del Académico"[3] establece como sanciones la amonestación verbal, amonestación escrita, multas o suspensión sin goce de remuneraciones y la desvinculación (art. 26). En estos casos será el Comité de Ética de la Facultad el que decidirá las sanciones correspondientes.

Por otra parte, la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Discriminación, Violencia Sexual y de Género de la Universidad Diego Portales tiene por propósito asegurar estándares de respeto y convivencia, proporcionando mecanismos para prevenir, enfrentar y sancionar situaciones de discriminación basada en el género, incluyendo la violencia sexual y de género.

Para tales efectos, la normativa considera como conductas de violencia sexual todos aquellos comportamientos, palabras o gestos de connotación sexual no consentidos y que atentan contra la dignidad o integridad psicológica y/o física de los miembros, beneficiarios o contraparte de la Universidad (art.1). La normativa tipifica un conjunto de acciones de violencia sexual, entre las que se encuentran: el acoso sexual; la agresión sexual; la exhibición, exposición y voyerismo sexual; el acecho sexual; y, en general cualquier interacción con significado sexual no consentida[4].

Por su parte, entiende como violencia hacia las diversidades sexuales y de género cualquier acción que atente contra la vida, integridad física o psíquica, o la libertad sexual de una persona. Esta se ejerce tomando en consideración el sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género de una persona (art. 9).

La UDP también dispone de una página web que contiene información relevante sobre la normativa, los consejeros/as de cada Facultad encargados de entregar orientación, el protocolo de actuación y procedimiento de investigación: http://noalaviolenciasexual.udp.cl/

[3] El Reglamento del Académico se encuentra disponible en: https://www.udp.cl/wp-content/uploads/2017/11/Reglamento_del_Academico.pdf

[4] La Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Discriminación, Violencia Sexual y de Género se encuentra disponible en: https://genero.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2019/01/RESOLUCIO%CC%81N-DE-RECTORI%CC%81A-N%C2%BA-43-NORMATIVA-PREVENCION-Y-SANCION-ACCIONES-DE-VIOLENCIA-SEXUAL-DIC-2018.pdf

3. POLÍTICA DE INCLUSIÓN PARA ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD[5]

Se solicita a los/las profesores tener en consideración y aplicar las directrices de la UDP contenidas en su Política de Inclusión para Estudiantes, Académicos y Administrativos en situación de discapacidad, la que sigue las orientaciones de la Ley N°20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

Esta ley define una persona en situación de discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras ve impedida o restringida su participación plena y efectiva.

La UDP cuenta con una Unidad de Apoyo a la Discapacidad (UAD), que tiene por misión orientar y apoyar de manera prioritaria a los y las estudiantes en situación de discapacidad, y a las unidades académicas y administrativas donde se desenvuelven, promoviendo en la Universidad una cultura inclusiva que facilite el ingreso, progresión, egreso, inserción laboral y formación continua de estos estudiantes.
De acuerdo a esta política, las unidades académicas “deberán informar a los estudiantes sobre la política de inclusión, derivándolos cuando corresponda, a las unidades a cargo de brindar servicios de apoyo especializado. A su vez, los docentes y profesionales que interactúen directa o indirectamente con estudiantes en situación de discapacidad podrán solicitar orientación a la UAD para realizar ajustes que faciliten la plena inclusión académica de estos estudiantes”.

[5] http://inclusiva.udp.cl/politica-de-inclusion-udp/

VII. Contenidos:

SESIÓN	UNIDAD	CONTENIDOS	LECTURA MINIMA	TRABAJO PERSONAL PREVIO	TEXTOS PRESENTACIONES
1 **11.8**	INTRODUCCION AL CURSO	**Contexto y perspectivas en neuropsicología clínica.** Antecedentes históricos y desarrollo de la disciplina. La NPC en Chile y el mundo: formación. Competencias genéricas y específicas. ¿Por qué Chile necesita Neuropsicolog@s clínic@s?	Salas, C. E. (2014). Rehabilitación Neuropsicológica en Chile: una disciplina latente. *Revista Chilena de Neuropsicología*, *9*(1), 1-3.		
2 **18.8**	Unidad 2 NEUROANATOMIA	**Panorámica de Neuroanatomía Funcional.** Organización estructural y funcional del SNC	Solms & Turnbull (2002) Cap. 1 introducción a Conceptos Básicos. *El Cerebro y el Mundo Interior. Una introducción a la neurociencia de la experiencia subjetiva* *PÁGINA DE REFERENCIA NEUROANATOMIA FUNCIONAL* *https://www.neuroanatomy.ca*	CAPSULA PANORAMICA FUNCIONAL Revisar página y realizar Test Yourself (Neuroanatomia General) https://www.neuroanatomy.ca/modules/CNSintro/story.html Revisar página y realizar Test Yourself (Corteza) https://www.neuroanatomy.ca/modules/Cortex/story.html	
3 **25.8**	Unidad 2 NEUROPATOLOGIA	**Principales Síndromes Neuropatológicos en el Adulto I. Perfiles Neuropsicológicos.**TEC, AVE, Encefalitis, Tumor. Virus (HIV, COVID-19)	Ardila & Rosselló (2007) Cap. 2. Patologías Neurológicas. En Neuropsicología Clínica. México: Manual Moderno.	CAPSULA 1 SINDROMES NEUROPATOLÓGICOS Revisar página y realizar Test Yourself (GANGLIOS DE LA BASE) https://www.neuroanatomy.ca/modules/BasalGanglia/story_html5.html Revisar página y realizar Test Yourself (SISTEMA LIMBICO) https://www.neuroanatomy.ca/modules/LimbicSystem/story_html5.html	

4 1.9	Unidad 2 NEUROPATOLOGIA	**Principales Síndromes Neuropatológicos en el Adulto II. Perfiles Neuropsicológicos.** Esclerosis Múltiple, Epilepsia, Demencias, TDAH Adulto.	Mitchell, W. (2018) Alguien a quien solía conocer. Pp. 7-70	CAPSULA 2 SINDROMES NEUROPATOLÓGICOS	
5 **8.9**	UNIDAD 3 CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS DEL ADULTO	**Trastornos Neurológicos y participación social.** Integración a la comunidad**,** Independencia, Actividades de la Vida Diaria, Productividad (educación, trabajo) y Ocio. Aislamiento Social.	Cap. 12 Promoción de la funcionalidad en la persona con demencia (Telllo et al.,) En Budinich, M., Aravena, J., Gajardo, J. & Fuentes, P. (2019) Demencias: una mirada biopsicosocial. Mitchell, W. () Chapter Environment (pp. 78-87). In What I wish people knew about dementia.	How I made my Home Dementia Friendly (Wendy Mitchell) https://www.youtube.com/watch?v=k4pAaI11QeE HeadForward Personal Stories https://www.youtube.com/watch?v=4XgWzPVH-Gs	
15.9	RECESO FIESTAS PATRIAS				
6 **22.9**	UNIDAD 3 CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS DEL ADULTO	**Trastornos Neurológicos: problemas psicológicos e interpersonales.** Pérdida de la identidad, calidad de vida, sintomatología psiquiátrica**,** estigma internalizado. Impacto familiar y relacional: pérdida de la Intimidad, continuidad relacional.	Lassaletta, A. & Salas, C. (2019). La reconstrucción de la identidad. En Lassaletta, A. El daño cerebral invisible. EOS. Bracho-Ponce, M. J., Grasso-Cladera, A., Salas, C., & Lassaletta, A. (2022). 'No soy quien creen que soy': estigma público y daño cerebral invisible. *Studies in Psychology*, *43*(1), 35-54	Riley Charla. Conectándose con el pasado: los beneficios de mantener links con la vida previa a la lesión https://youtu.be/pNJuzYtCdBk	
7 **29.9**	UNIDAD 4 FUNDAMENTOS EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	**Fundamentos y Principios de la Evaluación Neuropsicológica I.** La entrevista clínica. El examen mental. Formulación de hipótesis.	Hebben & MIlberg (2011). Cap. 3 Elementos esenciales de la entrevista y del historial clínico. Editorial manual moderno: México DF	CASO Membila et al., (XXXX). Ch. 21. Demencia Tipo Alzheimer. Conservar algo que me ayude a recordar. En Arnedo, Bembire & Triviño (Eds)Neuropsicología a través de casos clínicos.	
8 **06.10**	UNIDAD 4	**Fundamentos y Principios de la Evaluación Neuropsicológica II.**	Ardila & Hebben & MIlberg (2011). Cap. 4 Elementos	CASO	

	FUNDAMENTOS EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	Enfoques en la evaluación neuropsicológica (localización, psicometría, proceso, ecologicidad). Tipos de tests: usos y limitaciones (tests de tamizaje, baterías fijas, baterías flexibles, tests específicos, tests ecológicos, cuestionarios paciente e informante). Evaluación de funcionalidad.	esenciales de la selección de pruebas, la administración y la calificación. Editorial manual moderno: México DF	Bembire & Arnedo (XXXX) Ch. 14. Neuropsicología de la Corteza prefrontal Dorsolateral I. ¿Problemas Yo?. En Arnedo, Bembire & Triviño (Eds)Neuropsicología a través de casos clínicos. Bembire & Arnedo (XXXX) Ch. 15. Neuropsicología de la Corteza prefrontal Dorsolateral II. ¿Mañana? No se. En Arnedo, Bembire & Triviño (Eds) Neuropsicología a través de casos clínicos.	
9 **13.10**	CERTAMEN				
10 **20.10**	UNIDAD 4 FUNDAMENTOS EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	**Fundamentos y Principios de la Evaluación Neuropsicológica III.** Devolución de Evaluación Neuropsicológica. Construcción de una Formulación	Postal & Armstrong (2013) Chapter 1 and 2 Feedback that Sticks. Oxford	Culturally Competent Neuropsychological Feedback https://www.youtube.com/watch?v=mALJ9VBfEu4 (subtitulos disponibles)	
11 **27.10**	UNIDAD 5 FUNDAMENTOS REHABILITACION NEUROPSICOLOGICA	**Rehabilitación Neuropsicológica I.** Principios de recuperación. Rehabilitación Cognitiva. Rehabilitación Holista.	Wilson, B. A., Mac Auliffe, M., & Salas, C. (2020). Principios generales de la rehabilitación neuropsicológica. *Cuadernos de Neuropsicología*, *14*(2). Wilson, Winegardner & Ashworth (2014) Chapter 5. Kate's story. Recovery takes time, so don't give up.	Clase Jon Evans Rehab Basada en la Evidencia (español traducción) https://www.youtube.com/watch?v=OS12rv52oZo ingles https://www.youtube.com/watch?v=xdh0Z2fMqJk&t=633s	

12 **3.11**	UNIDAD 5 FUNDAMENTOS REHABILITACION NEUROPSICOLOGICA	**Rehabilitación Neuropsicológica II.** Tipos de Servicios de Rehabilitación Formal e Informal. Rehabilitación laboral y educacional. **Trabajo multidisciplinario**. El equipo de rehabilitación. Trabajar inter, multi o trans. El rol del neuropsicólogo clínico en un equipo de rehabilitación. ¿Qué hace a un buen terapeuta de personas con trastornos neurológicos?	Turnbull, Coetzer and Salas (2023) This is not neuropsychological rehabilitation. In Mistakes in Clinical Neuropsychology: a case based approach. Jiménez, L., Salas, C., Maldonado, M., Moya, A., Lagos, S., Herrera, C., ... & Moreno, S. (2010). Enfoques y fundamentos para un modelo de rehabilitación ambulatoria en personas con lesión cerebral adquirida. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, (10), ág-57.	CLINICA LOS COIHUES https://www.youtube.com/watch?v=kdoO4HEbSgI INRPAC https://www.youtube.com/watch?v=6bZAfaAFqSA Rehab Socio-Laboral https://www.youtube.com/watch?v=y-DVZbwo-3c Rehabilitacion basada en la comunidad https://www.youtube.com/watch?v=DH8JIKOIW18 Headway Support Group Stockport https://www.youtube.com/watch?v=gU-WInU0r_o&t=2s	
13 **10.11**	UNIDAD 6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TECNICOS DE LA INTERVENCIÓN EN NEUROPSICOLOGIA CLINICA (INHIRA)	**Teoría del cambio psíquico**. Ajuste emocional y teorías de duelo. La relación entre cambio psíquico y funcionalidad en la vida real. Del síntoma al significado. La reconstrucción de identidad. Intimidad y pertenencia.	Klonoff, P (2010) Chapter 1 Introduction and overview. In Psychotherapy after brain injury. García-Molina, A., & Salas, C. (2023). Rehabilitación neuropsicológica en el daño cerebral adquirido:¿ una cuestión de identidad?). *Studies in Psychology*, *44*(1), 112-134.	Daño Cerebral Invisible por Aurora Lassaletta https://www.youtube.com/watch?v=Nv_m9BMAO8U	
14 **17.11**	UNIDAD 6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TECNICOS DE LA INTERVENCIÓN EN NEUROPSICOLOGIA CLINICA	**Terapias psicológicas individuales en trastornos neurológicos.** El modelo genérico de psicoterapia y su uso en personas con trastornos neurológicos. Modelos teóricos en psicoterapia y adaptaciones técnicas. Intervenciones basadas en la evidencia. Intervenciones Neuro-conductuales.	Salas, C. (2008). Psicoterapia e intervenciones terapéuticas en sobrevivientes de lesión cerebral adquirida. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, *46*(4), 293-300. García Molina et al., (2014). Neuropsicoterapia en la	¿Puede el daño cerebral cambiar aspectos esenciales de la personalidad? Igor Bombin https://www.youtube.com/watch?v=CAGfQ83_CqA	

			rehabilitación del daño cerebral.		
15 **24.11**	CERTAMEN 2				
16 **1.12**	UNIDAD 6 INTERVENCIONES PSICOLOGICAS	**Intervenciones familiares**. Necesidades de la familia en LCA y Demencia. Distintos sub-sistemas tienen distintas necesidades. Psicoeducación. Intervenciones psicológicas al sistema familiar.	Mitchell, W. (XXXX) Chapter Relationships. Pp. 31-49. What I wish people knew about dementia. Norup, A. (2018). La Familia Importa en Neurorrehabilitación: por qué, cuando, quién y cómo?. *Revista Iberoamericana de Neuropsicología*, *1*(1), 17-31.	**Introduction to the impact of brain injury on families** https://www.youtube.com/watch?v=xFHfEWLghYI **Relationships After Stroke Q&A: Partner to Patient- The Changing Dynamics.** https://www.youtube.com/watch?v=MyHLQ9p7US8 **Relationships & Sex After Stroke Q&A:" My Partner Feels Like A Stranger."** https://www.youtube.com/watch?v=upnX6aXOmag **Relationships After Stroke Q&A - " Can Our Relationship Survive?"** https://www.youtube.com/watch?v=v3pcb2yJsQM	
17 **8.12**	RECUPERATIVA SOLEMNES				
15/12- **20/12**	EXAMENES				